EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 86143
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-06 11:57:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LORENZO ABELARDO PARRA HERRERA			RUN	: 7.590.873-3
F.Nac	: 15-09-1954	Edad	: 69 AÑOS, 8 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: CAM TRAPICHE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 66048637		
Fecha Ingreso	: 2024-05-31	Fecha Egreso	: 2024-06-06 11:57:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ACV ISQUEMICO FRONTO-PARIETAL CORTICO-SUBCORTICAL IZQUIERDO TROMBOLIZADO
2. ESTENOSIS SIGNIFICATIVA DE ARTERIA CARÓTIDA INTERNA IZQUIERDA (APROX 80%) CON INDICACION DE ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA (SINTOMÁTICA)
3. DM2 IR BIEN CONTROLADA
4. HTA MODERADA
5. HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO
6. OBESIDAD MORBIDA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I60-I69-ENFERMEDADES CEREBROVASCULAR (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I65.2-OCLUSION Y ESTENOSIS DE ARTERIA CAROTIDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

mRS 0, VIVE CON FAMILIARES, JUBILADO, CONSULTA EL 30.05.24 TRAS PRESENTAR DE FORMA BRUSCA DIFICULTAD PARA HABLAR Y MOVILIZAR HEMICUERPO DERECHO, INGRESA A URGENCIAS EN PERÍODO DE VENTANA, PA 156/90, HGT 197, EVALUADO POR TELENEUROLOGIA, NIHSS 9 (DISARTRIA, PFC DERECHA, M0 BRAZO DERECHO, M3+ CRURAL DERECHO), TC CEREBRO HIPODENSIDAD ANTIGUA PERIVENTRICULAR IZQUIERDA, ANGIOTC DESCRITO SIN ESTENOSIS SIGNIFICATIVA, SE INDICA TROMBOLISIS 0,9 MG /KG (DOSIS MAXIMA 90 MG) SIN INCIDENTES, SE DERIVA A UCI HSC PARA CONTINUAR MANEJO Y ESTUDIO DE ACV ISQUÉMICO.
DURANTE HOSPITALIZACIÓN CON MEJORÍA CLÍNICA PROGRESIVA, CON AUMENTO GRADUAL DE ANTI-HTA, TC CEREBRO CONTROL MUESTRA HIPODENSIDADES MENORES EN CORTEZA PRE Y POSTCENTRAL IZQUIERDA Y ALGUNAS SUBCORTICALES, SIN TRANSFORMACION HEMORRAGICA, SE REVISA ANGIOTC CUELLO Y CEREBRO, DESTACANDO ESTENOSIS APROXIMADA DE 80-85% EN ORIGEN DE ACI IZQUIERDA.
SE PRESENTA CASO A CARDIOLOGÍA, QUIÉN REALIZA ECOCARDIOGRAMA SIN ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS, INDICANDO PASE CARDIOLÓGICO PARA EVENTUAL ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA IZQUIERDA. ADEMÁS SE CONVERSA CON DRA. URDANETA (CIRUJANA VASCULAR HCHM) QUIEN INDICARÁ SI EXISTE POSIBILIDAD DE PABELLON EN PRÓXIMOS DÍAS. SE EXPLICA CONTEXTO ACTUAL AL PACIENTE QUIEN ACEPTA INDICACIÓN QUIRÚRGICA.
ACTUALMENTE AL EXAMEN NEUROLÓGICO CON DISARTRIA LEVE, PFC DERECHA LEVE, M3+ BRAQUIAL DERECHO CON MAYOR PARESIA DISTAL, TONO Y ROT SIMETRICOS, M4+ CRURAL DERECHA CON PLANTAR EXTENSOR DERECHO, SIN COMPROMISO SENSITIVO. POR ESTABILIDAD CLÍNICA Y

NECESIDAD DE MANTENER REHABILITACIÓN KINÉSICA, INDICO HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA.
* SE RETIENE TELEFONO DE PACIENTE PARA DEFINIR GESTIÓN CON HCHM EN PRÓXIMOS DÍAS***

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. REPOSO EN DOMICILIO, SENTAR BORDE CAMA, LEVANTAR CON APOYO ASISTIDO SEGUN INDICACIÓN KINÉSICA
2. 2. REGIMEN LIVIANO, DIABÉTICO E HIPOSÓDICO
3. 3. LOSARTAN 50 MG VO C/12 HRS
4. 4. HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG VO DIA
5. 5. CARVEDILOL 6,25 MG C712 HRS
6. 6. AMLODIPINO 10 MG VO DIA
7. 7. METFORMINA 850 MG VO C/8 HRS CON COMIDAS
8. 8. MANTENER DOSIS INSULINA NPH 20 U AM- 10 U PM SC
9. 9. ASPIRINA 100 MG VO DIA
10. 10. CLOPIDOGREL 75 MG VO DIA
11. 11. ATORVASTATINA 80 MG VO DIA
12. 12. FAMOTIDINA 40 MG VO DIA
13. 13. CELECOXIB 200 MG VO SOS EN CASO DOLOR INTENSO
14. 14. PENDIENTE INFORME HOLTER DE RITMO
15. 15. SLOW K 600 MG VO C/12 HRS
16. 16. CONTROLAR ELP POR HODOM -> AJUSTE MANEJO HIPOKALEMIA LEVE
17. 17. DERIVO HODOM + KINESIOLOGIA MOTORA + FONO DIARIO
18. 18. CONTROL AL ALTA DE HODOM POR NEUROLOGIA (SE AVISARÁ FRENTE POSIBILIDAD DE RE-HOSPITALIZAR EN HCHM PARA MANEJO QUIRURGICO)
19. 19. SOLICITO BASTON Y SILLA DE RUEDAS

EXÁMENES Y RESULTADOS

ECG: RITMO SINUSAL
CREA 1,4,BUN 20, UREMIA 43
COL TOTAL 168, HDL 39, LDL 53, TG 378
NA+ 143, K+ 3,1 , CL- 109
HTO 36,2%, LEUCOCITOS 8500, PLAQEYTAS 182.000
INR 1,1, PROTROMBINA 80%
TSH 6,2, T4L 0,6
HEMOGLOBINA GLICOSILADA 7,5%
ECOCARDIOGRAMA 06.06.24: FEVI 65%, VI NO DILATADO CON HIPERTROFIA CONCENTRICA, AI LEVEMENTE DILATADA, FUNCION DIASTOLICA NORMAL, ESCLEROCALCIFICACION MITROAORTICA, CAVIDADES DERECHAS NO DILATADAS, SIN SIGNOS HT PULMONAR.

NATALIA BEATRIZ HERNANDEZ LAGOS
MEDICO TRATANTE
15877858-0

JEFE SERVICIO